

心血管病人多重用藥的減藥策略

Deprescribing in CVD Experiencing Polypharmacy

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-11

AHA Scientific Statement | Circulation 2026;154

原文連結：[DOI 10.1161/CIR.0000000000001459](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001459)

核心觀念

- 多重用藥 (polypharmacy) = 長期用 ≥ 5 種藥 ; hyperpolypharmacy = ≥ 10 種
- CVD 病人是所有疾病中多重用藥盛行率最高的族群
- 與不當處方、順從性下降、CVD 控制變差、生活品質降低、不良預後相關

減藥 (deprescribing) = 在監督下停用或減量藥物。AHA 背書為高品質心血管照護的關鍵一環。
目標不是「少開藥」，而是提升處方品質。

多重用藥有多普遍？

族群	盛行率
美國成人 1999→2018	8.2% → 17.1%
≥65 歲 (2009→2018)	23.5% → 44.1%
CVD 成人 (2017)	61.7% (最高)
HF 病人	74% (門診) ~ 84% (住院)
HFpEF 年長者	hyperpoly 76% ; 100% ≥1 PIM

驅動因素：多重共病、GDMT 疊加、多開方者、照護轉銜不良、**處方瀑布**、自動續方

GDMT 如何堆疊藥量

疾病	核心藥物
高血壓	Thiazide / ACEI·ARB / DHP CCB / MRA
HFrEF	β -blocker / ARNI·ACEI·ARB / MRA / SGLT2i
缺血性心臟病	Aspirin / β -blocker / ACEI·ARB / nitrate / P2Y ₁₂
AF	抗凝血劑 / β -blocker / non-DHP CCB
血脂異常	Statin (+ezetimibe/PCSK9i)

共病連鎖：高血壓/血脂 → 冠心病 → HF → AF，每環各有 GDMT + 非心血管共病 → **多重用藥難以避免**

一線希望：GLP-1 RA、SGLT2i「一藥多用」；長效注射劑取代每日口服

多重用藥的不良後果

- **臨床事件**：年長 AF (≥ 9 種藥) 全因死亡、大出血、出血風險 $\uparrow$ $\rightarrow$ 惡性循環 (多重用藥 $\rightarrow$ 不順從 $\rightarrow$ ADE)
- **HFpEF**：hyperpolypharmacy $\rightarrow$ 住院率 $\uparrow$
- **順從性**：藥物數與順從率呈**反比**
- **經濟**：年長 CVD + 多重用藥 年度醫療支出 **2 倍 (\$19,068 vs \$8,815)**
- **衰弱 (frailty)**：與多重用藥雙向關係，併存預後更差

誰該考慮減藥？

四類病人（減藥觸發點）

1. **已發生 ADE** — 常非特異/無症狀，易誤為老化；**反覆跌倒**要警覺
2. **多重用藥 / PIM** — 藥物已無適應症、效益有限、風險不成比例、不符病人優先順序；合併認知障礙者優先
3. **處方瀑布** — 新藥後出現新症狀 → 想是否為藥物引起，別再加一顆藥
4. **安寧 / 末期** — 目標轉向症狀控制與減少負擔；反覆住院也是時機

找出可減的藥：調節 + 工具

藥物調節 (medication reconciliation) 4 步驟：

Verify (最完整用藥史) → Identify (比對差異)
→ Reconcile (協同決策) → Communicate (記錄溝通)

辨識 PIM 工具 (Table 2)：

- **Explicit** (明確規則)：AGS Beers、STOPP/START、FORTA
- **Implicit** (臨床判斷)：MAI
- 「病人為中心 (patient-in-focus)」列表法 RCT 結果較佳

工具輔助而非取代臨床判斷

善用「過期適應症」

情境	可能不再需要的藥
AF 房室結電燒後	rate-slowing 藥、抗心律不整藥
PCI 後心絞痛已解	長效硝酸鹽、ranolazine
PCI 後 (技術進步)	縮短 DAPT 療程
MI 保留 EF	β -blocker 長期角色不確定
初級預防	aspirin 風險可能 > 效益

Table 3：可減的心血管藥物

藥物	理由	漸減
α -blocker	姿勢性低血壓	否
clonidine	CNS 反應、低血壓、心搏過緩	是
抗心律不整藥	電燒後、永久 AF、HFrEF	否
抗凝血劑	LAA 關閉後、VTE 完成、風險>效益	否
aspirin	初級預防、已用抗凝、>100mg	否
β -blocker	無併發症 MI 保留 EF >3y、HFpEF、AVN 電燒後	是
digoxin	進階腎病毒性 (eGFR<30)	否
長效硝酸鹽/ranolazine	PCI 後無症狀	否

Table 3：可減的非心血管藥物

藥物	理由
抗膽鹼藥 (>1)	認知障礙、跌倒、譫妄
CNS 活性藥 (≥3)	跌倒、骨折
gabapentinoids	HF、跌倒
NSAIDs (慢性)	HF、缺血性心臟病、GI 出血
PPI (長期無症狀)	C. diff、肺炎、骨折風險
thiazolidinediones	HF
保健品/維生素	紅麴 + statin、魚油、CoQ10...

治療競爭經典例：NSAID 治關節炎卻惡化 HF/冠心病

如何安全地減藥（漸減與 ADWE）

- 減藥需**監督**，留意**藥物戒斷事件 (ADWE)** 與反彈，多可用**漸減**避免
- **β -blocker**：突停高劑量 metoprolol 有**猝死**風險 → 受體半衰期 1.5 天，**每週減 50%**
- **Amiodarone**：半衰期 60 天 → **不需漸減**
- 減藥期間**監測**原疾病新/惡化症狀（ADWE）→ 可放慢、停在低劑量、或重新啟用

共享決策 + 團隊

- **92%** Medicare 病人願意停掉至少 1 種藥；HFpEF **90%** 願意；藥物越多意願越高
- SDM 要同時講**效益**（少副作用、順從性/生活品質）與**風險**（症狀復發、疾病進展）
- **團隊減藥**：藥師、護理師辨識 PIM、設計漸減、衛教/監測 ADWE
- 藥師主導計畫 RCT：出院後用藥數與 PIM 顯著↓、維持至 90 天；**社區藥師**尤其有價值

減藥的安全性證據

情境	證據
Aspirin 停用	初級預防：停用者 MACE 可能 ↑
Statin 停用	餘命 < 1 年似安全；長期不明，非隨機顯示 MACE ↑
抗高血壓藥停用	HF 風險 ↑；MI/中風/死亡無差異
HFimpEF 停 GDMT	HFrEF 復發

決策必須**個別化** + SDM + **密切監測** + 多專科團隊；仍需更高品質證據

Take-Home Messages

1. CVD 多重用藥盛行率最高 (61.7%) ; = 更多 ADE、更差順從、2 倍支出
2. 減藥 = 提升處方品質，是 optimal prescribing 的一部分 (AHA 背書)
3. 四觸發點：ADE、PIM、處方瀑布、安寧；用 Beers / STOPP-START 找 PIM
4. 漸減有學問： β -blocker 每週減 50%；amiodarone 免漸減；監測 ADWE
5. 92% 病人願停藥；SDM + 藥師/護理師團隊是關鍵

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

DiDomenico RJ, et al. AHA Scientific Statement. Circulation 2026;154 — DOI

參考文獻

1. DiDomenico RJ, Marrs JC, Bress AP, et al; on behalf of the AHA Clinical Pharmacology Committee. Deprescribing in Patients With Cardiovascular Disease Experiencing Polypharmacy: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2026;154:e00–e00.
2. Krishnaswami A, et al. Deprescribing in older adults with cardiovascular disease. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73:2584–2595.
3. Scott IA, et al. Reducing inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing. *JAMA Intern Med*. 2015;175:827–834.
4. O'Mahony D, et al. STOPP/START criteria version 3. *Eur Geriatr Med*. 2023;14:625–632.

本投影片為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考，非臨床診療指引。